l'Assurance Maladie
Agir ensemble, protéger chacun
Caisse nationale

Fiche technique de l'indicateur
Catégorie : **Vaccination**
Trigramme : **HPV**
Version : **1.0**

I. Description

Parmi les adolescents de 11 à 15 ans inclus (< 16 ans), l'indicateur est validé pour ceux ayant reçu au moins deux doses, à au moins 3 mois d'intervalle, de vaccin HPV entre 10 et 14 ans inclus (avant 15 ans).

II. Critères de ciblage

1. Population cible

« *Parmi les adolescents de 11 à 15 ans inclus (< 16 ans) […]* » :

- Age ≥ 11 ans ET < 16 ans

2. Critères d'exclusion

Pas de critère d'exclusion pour cet indicateur.

3. Critères de réalisation de l'acte de prévention

« *[…] ayant reçu au moins deux doses, à au moins 3 mois d'intervalle, de vaccin HPV entre 10 et 14 ans inclus (avant 15 ans).* » :

- Au moins deux doses de vaccin contre les papillomavirus humains, administrées à au moins 3 mois d'intervalle l'une de l'autre, depuis le 1er jour du mois du 10ème anniversaire et jusqu'au dernier jour du mois du 15ème anniversaire, parmi :
  - Vaccination contre les HPV réalisée dans le cadre de la campagne de vaccination au collège (codes de facturation = « **HP1** » ou « **HP2** »)
    OU
  - Délivrance d'une dose de vaccin contre les HPV (classe ATC = « **J07BM** »)

III. Modalités de rémunération (FMT – Majoration Prévention)

Pour chaque patient « médecin traitant » de 11 à 15 ans au 31/12 de l'année N, le médecin est rémunéré si le patient a reçu au moins deux doses de vaccin contre les papillomavirus humains, administrées à au moins 3 mois d'intervalle l'une de l'autre, entre le 1er jour du mois de son 10ème anniversaire et le dernier jour du mois de son 15ème anniversaire.

IV. Explications complémentaires

1. Argumentaire

L'objectif de cet indicateur est de permettre au médecin traitant de suivre la vaccination contre les papillomavirus humains (HPV) parmi ses patients éligibles à cette vaccination.

Conformément aux recommandations en vigueur, la vaccination contre les HPV est recommandée pour toutes les filles et tous les garçons de 11 à 14 ans révolus, selon un schéma à deux doses espacées de 5 mois. Un rattrapage reste possible au-delà, selon un schéma à trois doses. Autrement dit, un adolescent éligible est considéré comme « à jour »

dès lors qu'il a reçu deux doses de vaccin contre les HPV avant son 15ème anniversaire. Afin de tenir compte des conditions réelles d'administration des deux doses, l'intervalle minimal retenu entre les deux doses est de 3 mois, et les bornes d'âge sont appréciées au mois près et non au jour près.

Le ciblage de la population éligible s'appuie sur le calendrier vaccinal élaboré par le ministère chargé de la santé. Il s'agit de tous les adolescents de 11 à 15 ans inclus, sans distinction de sexe. La borne haute de la population cible (< 16 ans) est volontairement postérieure à la borne haute de réalisation des doses (avant 15 ans), afin que le médecin traitant conserve une visibilité sur le statut vaccinal de ses patients au-delà de l'âge auquel le schéma recommandé doit être achevé.

2. Documents de référence

L'indicateur s'appuie sur les documents suivants :

- Calendrier des vaccinations : https://sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/calendrier-vaccinal

3. Limites

Ces indicateurs de prévention sont calculés à partir des données de remboursement de l'assurance maladie, qui ont l'avantage de couvrir l'ensemble de la population assurée, tous régimes confondus.

Cependant, par construction, elles ne retracent que les soins qui ont fait l'objet d'une facturation à l'assurance maladie.

Tout acte ou prestation réalisé hors de ce circuit ne sera pas pris en compte dans le calcul, et en particulier :

- Les soins réalisés à l'étranger ;
- Les soins prodigués au sein de certaines structures qui ne facturent pas à l'assurance maladie (médecine du travail, PMI, médecine scolaire ou universitaire, etc.) ;
- Certains soins sans codage spécifique prodigués lors d'un séjour en établissement (actes cliniques, certains actes techniques ou de biologie financés dans le cadre du séjour, médicaments délivrés par la pharmacie interne de l'établissement, etc.).

De même, les informations contenues dans le dossier médical du patient, y compris les résultats d'examen, et y compris les documents stockés dans son dossier médical partagé ou dans « Mon Espace Santé », ne seront pas prises en compte dans le calcul.

Par ailleurs, certains professionnels ou certaines structures de soins peuvent facturer les soins réalisés de façon différée (à une date ultérieure) : cela ne fausse pas la date de réalisation du soin, mais il faudra alors attendre que l'acte ait été effectivement remboursé pour qu'il puisse être pris en compte dans le calcul.

Enfin, indépendamment du délai de facturation de l'acte par le professionnel, il existe aussi un certain délai pour que l'information soit traitée et mise à disposition, et qu'elle puisse ainsi être prise en compte dans le calcul.

En pratique, pour toutes ces raisons, il peut y avoir un écart entre les données restituées et la situation réelle du patient à un instant donné. Pour cet indicateur, les principales situations susceptibles d'entrainer de tels écarts sont les suivantes :

a. Population cible

- Risque d'écart négligeable ;

b. Critères d'exclusion

- Pas de critère d'exclusion pour cet indicateur.

c. Critères de réalisation de l'acte de prévention

- Dose de vaccin administrée hors du circuit de facturation à l'assurance maladie (centre de vaccination, service de médecine scolaire ou universitaire, etc.) ;
- Dose de vaccin administrée dans le cadre d'un séjour en établissement, sans codage spécifique de l'acte.

V. Précisions techniques

Source : SNIIRAM

Champ de la requête : tous régimes – patients ayant un médecin traitant

Profondeur de la requête par rapport à la date de référence de la photo :

- Pour définir la population cible : aucune profondeur (âge uniquement)
- Pour les critères d'exclusion à prendre en compte : pas de critère d'exclusion
- Pour les actes traceurs à prendre en compte pour valider l'indicateur : 1er jour du mois du 10ème anniversaire
- Pour les actes traceurs à prendre en compte pour l'affichage : 1er jour du mois du 10ème anniversaire

Composants utilisés pour la requête :

- ✓ DCIR → tables de consommation de soins de ville qui permet de repérer les actes et prestations générales (codes NGAP ou autres codes de facturation), les actes techniques (codes CCAM), les actes de biologie (codes NABM), ou la délivrances de médicament (codes CIP ou classes ATC) ; les soins facturés au cours d'un mois donné sont disponibles au début du mois suivant pour les assurés du régime général, et à la fin du mois suivant pour les assurés affiliés aux autres régimes (notamment MSA).
- × IR_IMB_R → table du référentiel médicalisé qui permet d'identifier, en cas d'exonération du ticket modérateur (dont ALD), la pathologie précise (CIM10) associée.
- × PMSI → tables relatives aux soins et pathologies précises (CIM10) associées aux séjours réalisés dans les établissements de santé publics et privés ; les soins et séjours au cours d'une année sont disponibles à la fin du 1er semestre de l'année suivante.
- × SSU → données relatives aux formulaires d'exclusion des programmes nationaux de dépistages organisés des cancer ; ces formulaires sont fournis aux assurés pour qu'ils puissent signaler à l'assurance maladie un ou plusieurs motif(s) d'exclusion dont elle n'aurait pas connaissance.

VI. Acronymes

ALD : affections de longue durée

ATC : *anatomical therapeutic chemical* → système international de classification des médicaments, permettant de regrouper plusieurs médicaments par classe thérapeutique

CCAM : classification commune des actes médicaux

CIM10 : classification internationale des maladies, version 10

CIP : code identifiant de présentation → code permettant d'identifier un médicament précis

DCIR : datamart de consommation inter-régime

IR_IMB_R : table du référentiel médicalisé

MSA : mutuelle sociale agricole

NABM : nomenclature des actes de biologie médicale

NGAP : nomenclature générale des actes professionnels

PMSI : programme de médicalisation des systèmes d'information

PMI : protection maternelle et infantile → service départemental chargé d'assurer la protection sanitaire de la mère et de l'enfant

SNIIRAM : système national d'information inter-régime de l'assurance maladie